RG Hofte

Endring siden forrige versjon
Revidert. Endret fra FCF til mer generell fraktur, i informasjonstekst om når vi tar CT og kontraindikasjon for innadroterte bein.

Indikasjon	Smerte, preoperativ hofteprotese	*«Protesebekken» AP, Lauenstein*
	Postoperativ kontroll samt kontroll etter reponering	***Første postoperative kontroll:*** *«Protesebekken» AP, Innskutt* ***Første polikliniske kontroll:*** *«Protesebekken» AP, Innskutt, Lauenstein* ***Senere kontroller:*** *«Protesebekken» AP, Lauenstein*
	Skade og luksasjon	*Bekken AP, Innskutt*

«Protesebekken» AP		Illustrasjon settes inn her
INFORMASJON	CT tas ved mistanke om **fraktur** på alle pasienter over 60 år. Hos pasienter under 60 år kan CT overveies.	
POSISJONERING	Pasienten liggende rett på ryggen uten rotasjon i bekkenet, beinene roteres innover 15-20° med ca. 10cm mellomrom mellom tærne. Ved **smerte, artrose** og **preoperative bilder** brukes *kalibreringskule*. Den justeres til samme avstand fra detektor som trochanter major, og plasseres så langt opp mellom beina til pasienten som mulig. **OBS:** Ved spørsmål om **luksasjon** eller **fraktur i hofte/lår** er innadrotasjon av aktuelt bein kontraindisert.	
SENTRERING	I pasientens midtlinje, i høyde med collum femoris, 8-10cm distalt for spina iliaca anterior superior (ASIS)	
STRÅLERETNING	0°	
BILDEKRITERIER	Ingen rotasjon i bekkenet, begge trochanter major skal se like ut, inkluder ASIS samt så mye som mulig av femur. Ved spørsmål om **artrose, smerte** samt ved **preoperative bilder** inkluderes hele kalibreringskulen. Ved **postoperative kontroller** inkluderes hele hofteprotesen med eventuell sementering og 2cm nedenfor.	
KOMMENTAR	Ha med mest mulig femur for å avdekke eventuell patologi i femurskaftet før innsettelse av osteosyntesematerieale.	
LAUENSTEIN		Illustrasjon settes inn her
INFORMASJON		
POSISJONERING	Pasienten liggende rett på ryggen, aktuelt bein flekteres i kneet og abduseres ca.45° med foten plassert på innsiden av motsatt bein, så nære kneet som mulig, samt laterale femur nærme bordet.	
SENTRERING	I høyde med collum femoris, 8-10cm distalt for spina iliaca anterior superior (ASIS)	

STRÅLERETNING	0°	
BILDEKRITERIER	Collum femoris i profil og forkortet, overprojisert av trochanter major. Inkluder ca. 1/3 av femur, opp til ASIS lateralt og symfysen medialt. Ved **postoperative kontroller** inkluderes hele hofteprotesen med eventuell sementering og 2cm nedenfor.	
KOMMENTAR	I tilfeller der avstanden fra laterale femur til bordet blir stor, kan pasienten skrås litt mot aktuell side.	
INNSKUTT		Illustrasjon settes inn her
INFORMASJON		
POSISJONERING	Pasienten liggende rett på ryggen uten rotasjon i bekkenet, aktuelt bein roteres innover 15-20°, ikke aktuelt bein løftes med 90° fleksjon i kne og hofte. Detektor plasseres vertikalt, lateralt på pasienten, parallelt med collum femoris, med distale femur vendt ca. 45° fra detektor. **OBS:** Ved spørsmål om **luksasjon** eller **fraktur i hofte/lår** er innadrotasjon av aktuelt bein kontraindisert.	
SENTRERING	Midt på collum femoris, omtrent lysken, samt noe posteriort for midtfemur-området, avhengig av pasientstørrelse.	
STRÅLERETNING	0°. Mediolateral stråleretning under ikke aktuelt bein.	
BILDEKRITERIER	Acetabulum, caput femoris og collum femoris fremstilles godt. Trochanter major overprojiserer kun distale del av en forlenget collum femoris, med kun en liten del av trochanter minor synlig. Tuberositas Ischii, samt 1/3 av femur inkluderes. Ved **postoperative kontroller** inkluderes hele hofteprotesen med sementering og 2cm nedenfor.	
KOMMENTAR		
BEKKEN AP		Illustrasjon settes inn her
INFORMASJON	CT tas ved mistanke om **fraktur** på alle pasienter over 60 år. Hos pasienter under 60 år kan CT overveies.	
POSISJONERING	Pasienten liggende rett på ryggen uten rotasjon i bekkenet, beinene roteres innover 15-20°. **OBS:** Ved spørsmål om **luksasjon** eller **fraktur i hofte/lår** er innadrotasjon av aktuelt bein kontraindisert.	
SENTRERING	Midt på pasienten, i høyde ca. 5cm distalt for spina iliaca anterior superior (ASIS).	
STRÅLERETNING	0°	
BILDEKRITERIER	Hele bekkenet fremstilles uten rotasjon, med trochanter major i profil uten forkorting av collum femoris. L5 inkluderes øverst, samt noen centimeter distalt for trochanter minor nederst.	
KOMMENTAR		

Referanser

•

Vedlegg

V01	534 CT Bekken/ hofte (A.1.1/6.1.6.2.5-11)
V03	RG Bekken (A.1.1/6.1.3.4-01)

Slutt på Prosedyre